

VANIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO MAGALHÃES			
SINTOMAS / QUEIXAS	Dor de cabeça / Ansiedade / HAS / Tireoide / Ino.		
MEDICAMENTOS	Eutirox 200mg / Ritz / Duaguo / Estale		
pram (4anos)			
HORA QUE DORME:	23	HORA QUE ACORDA:	8h
BANHEIRO	1 à 2x	IAH=	90,5
TIPO DE RESPIRAÇÃO		SpO2	77%
PRÁTICA EXERCÍCIO	não faz		
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ:	5	ALMOÇO:	5
		LANCHE:	5
		JANTAR:	—
IDADE:	56a.	PESO:	90
		IAH:	90,5
		MALLAMPATI:	3
		SPO2:	
03/01	menopausa - 45anos.		
23	IAH= 54.5 → SpO2 84%		
26/01	P= 7.0		
23	IAH= 1.8 e/lu		
	m. de uso: 8:30'		
	Pressão art. ainda n alt.		
	Melhora da dor de cabeça / acorda (+) vezes.		
	fua		
24/05/24	P= 7,0 cmH2O		
	IAH= 2,1 e/lu		
	m. de uso: 8h 16m		
	Somente verificamos aparelho		
	Natasha		
16/07/24	P= 6,2 cmH2O		
	IAH= 3,2 e/lu		
	m. de uso: 7h 16'		
	Fuga = 3,3 lpm.		
	mantem a medicação		
	fua.		

Nicole Martuscelli de Almeida

Médica

CRM-MG: 62.814

1/5

a da Conceição Ribeiro
galhaes

Encamado paciente acma
eruda para adaptação de
HP.

Sugiro CPAP automático
em umidificador pressão
cmH₂O máscara oronasal

Atenciosamente,

Nicole Martuscelli de Almeida
CRM-MG 62814
CONTROLE 9611568

27/12/2022

ico

Altura: 1,70 m

ara o sono de 15 minutos
s, com eficiência do sono

1 despertares (índice de

om e a menor de 54 bpm.
e 0,0/hora associados a

o. Sendo 533 apnéias, 35
5/hora, sendo 84,9 apnéi-
os foi de 22,8 e a duração

ra e 4,8 hipopnéia/hora. O
0 segundos, com duração

le 92%, a maior de 99% e
aixo de 90% e 0,2 minutos
turações: 91,8/hora. Índice
92,0/hora.

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuada (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Ronco presente.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono normal.

Petrônio Pedro Magoga Filho
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 129264

Descrição do Exame Polissonográfico

1/5

Nome: VANIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO MAGALHAES			
Sexo: F	Idade: 55 anos	Peso: 90 Kg	Altura: 1,70 m
IMC: 31,1	Data do Exame: 22/08/2022	Exame: 11995_01	
Médico solicitante: DRA EUGENIA			

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 23:13:16 horas e encerrado às 06:02:11 horas, com latência para o sono de 15 minutos e latência para o sono REM de 335 minutos. O tempo total de sono foi de 376,5 minutos, com eficiência do sono de 91,7%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	1,1%	Até 5%
Estágio 2	94,2%	45 - 55%
Estágio 3	1,5%	> 15%
Sono REM	3,3%	20 - 25%
Eficiência do sono	91,7%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 18,5 minutos ocorreram **621 despertares (índice de 99,0 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 58 bpm, a maior de 68 bpm e a menor de 54 bpm. Foram identificados **0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0,0/hora associados a despertares.**

Ocorreram 568 eventos respiratórios, sendo 0 central, 568 obstrutivos e 0 misto. Sendo 533 apnéias, 35 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 90,5/hora**, sendo 84,9 apnéia/hora e 5,6 hipopnéia/hora e 0,0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 22,8 e a duração máxima de 41,8.

O Índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 96,0/hora, sendo 91,2 apnéia/hora e 4,8 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0,0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0,0 segundos, com duração máxima de 0,0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina foi de 95%**, sendo a saturação **média de 92%**, a **maior de 99%** e a **mínima de 77%**, permanecendo 90,0 minutos (21,9%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0,2 minutos (0,0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 571 dessaturações. Índice de dessaturações: 91,8/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 96,0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 92,0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuada (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Ronco presente
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono normal.

Henrique Pedro Magoga Filho
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 129264

Nome: VANIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO MAGALHAES
Data de Nascimento: 5-12-1966
IMC: 31,14
Sexo: Feminino
Data do exame: 16-11-2022

Peso: 90 kg
Altura: 1,70 m
Médico: DRA. NICOLE MARTUSCELLI DE
ALMEIDA
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 16-11-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 417,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 38,5 e 83,0 minutos. O tempo total de sono foi de 317,0 min, eficiência de 75,9% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,7%; estágio N2: 63,7%; estágio N3: 13,4%; sono REM: 20,2%. O índice de despertares foi de 48,1/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 54,5/hora, sendo 33 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 255 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e a mínima de 84%, permanecendo 4,5% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 50 - 62 bpm e NREM de 50 - 73 bpm.

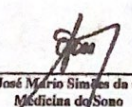
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (17), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. latência para o sono aumentada e latência para o sono REM diminuída;
4. aumento do número de despertares breves;
5. presença de atividade em EMG de queixo;
6. aumento do número de movimentos periódicos de membros inferiores (23,8/hora);
7. registro de ronco durante o sono.

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 14,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mário Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157